

NS

LEANDRO COSTANZI PETCOV

IDADE: 44 PESO: 114 ALTURA: 198 PROFISSÃO: Rep. Vendedor
 SINTOMAS: Falta de ar durante o sono / PIAS.
 QUEIXAS: Acorda muito humorado / Causado ao acordar
 MEDICAMENTOS: Raptix A / Coledui

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x Basquete (2x corrida)
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 19hs
 HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 6hs
 COCHILO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
 FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Sim BANHEIRO: 1X
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 53.4 e/lw SPO2: 71%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
 CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Rinite (rara/e)
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
 COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA celest 5 CARDÍACA HAS
 (N) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

alt. na memória
 12/04/23 Início

20/04/23 - P= 7.0 cm/H₂O
 m. de uso: 6h51'
 IAH= 1.6 e/lw
 Bem adaptado fua.

26/04/23 P= 7.2
 IAH= 1.9 e/lw
 m. de uso: 6h20'
 Bem adaptado fua.

17/05
 23 P= 6.3 cm/H₂O
 IAH= 2.5
 m. de uso: 6h38'
 Bem adaptado. fua

06/06
 23 P= 6.0
 m. de uso: 6h30
 IAH= 2.2 fua

09/08
 23 P= 7.0 cm/H₂O
 IAH= 1.6 e/lw
 m. de uso: 7h35'
 Bem adapt. fua

26/10 $P = 7,7 \text{ cmH}_2\text{O}$
23 $IAH = 1,9 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h30'
fuga = 11 l/min.

Bem adaptado.

fua.

08/01/24 $P = 6,8 \text{ cmH}_2\text{O}$ Perc 95%: $7,7 \text{ cmH}_2\text{O}$

$IAH = 2,0 \text{ e/h}$

m. de uso: 7h20' min

fuga: 18 l/min

Auto 5 à 7,8 cmH₂O
Bem disposto.

13/03 $P = 6,5$
24 $IAH = 1,0 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h

28/05/24 $P = 5 - 6,6 \text{ cmH}_2\text{O}$ Percentil 95% = $6,5 \text{ cmH}_2\text{O}$

$IAH = 0,9 \text{ e/h}$

m. de uso: 7h17m

fuga: 17 l/min

Bem adaptado

Natacha

01/08 $P = 5 - 6,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $IAH = 0,9 \text{ e/h}$
m. de uso: 16.1 e/h

Tubo max. / tubo

Filtro / Água

fua.

24/10 $P = 5,9 \text{ cmH}_2\text{O}$
24 $IAH = 0,8 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h50'
fuga: 16 l/min.

Verif. o filtro

Falta entregar o prong (m).
fua.

13/01 $P = 5,9 \text{ cmH}_2\text{O}$
25 $IAH = 1,0$
m. de uso = 7h

Bem adapt.

fua.

27/05/25 $P = 5,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h24'
fuga: 19,2 l/min

Bem adaptado

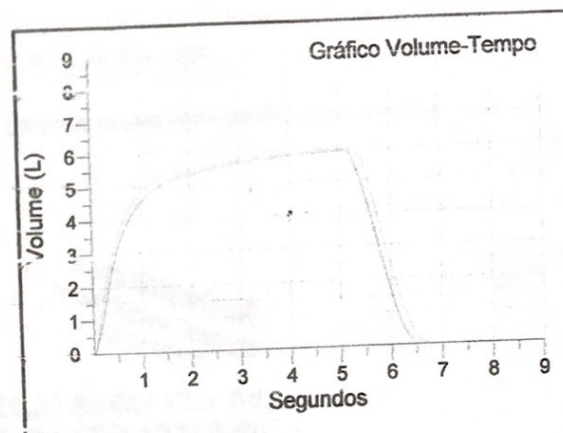
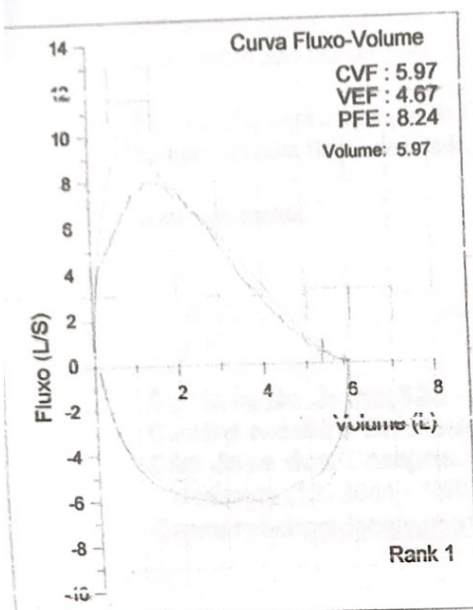
S/queiros

Natacha

CONSULTÓRIO DR. PAULO CESAR RIBEIRO DE CARVALHO
PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA
TELEFONE (12) 3941-1888

Informação do Paciente

Id: 3274 Nome: PETCOV, LEANDRO COSTANZ
 Etnia: Caucasiano Sexo: Masculino Altura: 197 Peso: 116 Idade: 44
 Comentários: AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM CHECKUP



Inspiratório	Real	Tempo do Teste
CVI	5.85 L	Tempo de Expiração: 5.08 s
PFI	6.18 L/S	Tempo de Inspiração: 1.54 s

Data/Horário do teste: 02/13/23 11:24:34

Previsto Utilizado	Data da Última Calibração
Pereira 2002	02/13/2023

Interpretação:
 Interpretação: NORMAL

Índice de Massa Corporea
 Índice de Massa Corporea: 29.8900 Kg/M²

PRÉ BD				PÓS DB				%	
Expiratório	Real	Previsto	% do Prev.	Expiratório	Real	Previsto	% do Prev.	Real	% Diferença
CVF	5.97 L	6.05 L	98.68 %	CVF	6.01 L	6.05 L	99.36 %	0.04 L	0.68 %
VEF 1.0	4.67 L	4.94 L	94.61 %	VEF 1.0	4.91 L	4.94 L	99.53 %	0.24 L	5.21 %
VEF 6.0	5.97 L	N/A	N/A	VEF 6.0	6.01 L	N/A	N/A	3.52 %	4.50 %
VEF 1.0/CVF	78.27 %	81.50 %	96.04 %	VEF 1.0/CVF	81.79 %	81.50 %	100.35 %	1.84 L/S	22.30 %
PFE	8.24 L/S	N/A	N/A	PFE	10.08 L/S	N/A	N/A	0.50 L/S	11.56 %
FEF25-75%	4.35 L/S	5.00 L/S	87.00 %	FEF25-75%	4.96 L/S	5.00 L/S	99.20 %		

Comentários do Médico

PROVA FUNCIONAL RESPIRATORIA DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE SEM RESPOSTA AO TESTE BRONCODILATADOR.

Paulo Cesar Ribeiro de Carvalho
 Pneumologia e Fisiologia
 CRM-SP 55350



14:45



DR Paulo Cesar R. de Carvalho CRM -SP 55350
Pneumologia e Tisiologia / Avaliação Funcional Pulmonar
 Titulo de Especialista em Pneumologia e Tisiologia pela SBPT/AMB desde 1986.
 Titulo de Especialista em medicina intensiva pela AMIB/AMB desde 1986

LEANDRO COSTANZI PETCOV
 SPPneumologiaPAULO CESAR RIBEIRO DE CARVALHO
 520, Jardim São Dimas, Sala 26, São José dos Campos - SP

29/03/202355350

Favor titular para adaptação de Cpap no paciente acima com quadro clínico e Psg
 compatível com Saos acentuada.

Atenciosamente.



Dr. Paulo Cesar R. de Carvalho
Pneumologia e Tisiologia
CRM-SP 55350
Av Nove de Julho, 520 - sala 26, 2º Andar Vila Adyanna -
Centro médico Dr. Nelson D'Avila CEP 12243-000 -
São Jose dos Campos.
Telefone: (12) 3941 - 1888
Comercial: pcrdecarvalho13@gmail.com / Pessoal: pcrdecarvalho@uol.com.br

Nome: LEANDRO COSTANZI PETCOV

Data de Nascimento: 13-2-1979

IMC: 30,10

Sexo: Masculino

Data do exame: 22-02-2023

Peso: 118 kg

Altura: 1,98 m

Médico: DR. PAULO CESAR RIBEIRO DE

CARVALHO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 22-02-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 514,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 30,5 e 201,0 minutos. O tempo total de sono foi de 366,5 min, eficiência de 71,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,7%; estágio N2: 61,7%; estágio N3: 16,1%; sono REM: 18,6%. O índice de despertares foi de 38,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 53,4/hora, sendo 84 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 39 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 88%, permanecendo 0,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 77 bpm e NREM de 44 - 84 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 53,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=88%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (21,6/hora);
8. presença de atividade em EMG de queixo;
9. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157